Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

HÉRNIAS DA PAREDE ABDOMINAL

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Meu querido aluno Estrategista,

Este é um RESUMO ESTRATÉGICO. O objetivo dele é focar nos principais temas que foram cobrados nos concursos de Residência sobre HÉRNIAS DA PAREDE ABDOMINAL.

Com este resumo, você será capaz de responder a cerca de 80% das questões que caírem sobre o tema; dos 20% faltantes, garanto que 10% são questões que a banca cobra tão pouco que, se aparecerem, será quase como um evento, e os outros 10% são devaneios e rodapés de artigos e livros. Para aprender sobre esses 20%, é necessário dar uma lida no livro digital, em que você encontrará o material completo e detalhado.

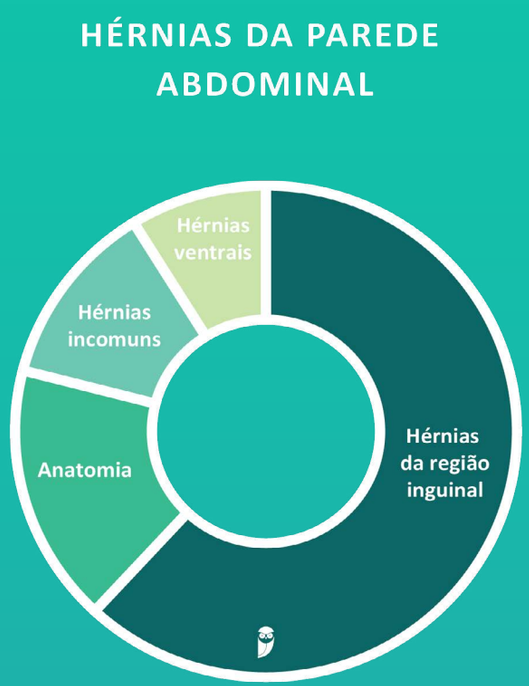
Neste resumo, focaremos em:

- Hérnias da região inguinal (inguinal e femoral);
- Hérnias ventrais (incisional, epigástrica, umbilical); e
- Hérnias incomuns e "especiais".

@proftomascoelho
@estrategiamed
Estratégia MED
/estrategiamed
@estrategiamed
t.me/estrategiamed

Estratégia MED

Essa ordem foi proposta a partir da prevalência de cada um desses temas nas provas de Residência:



Vamos lá?

"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles.

SUMÁRIO

1.0 O QUE É UMA HÉRNIA? 5
2.0 HÉRNIAS DA REGIÃO INGUINAL 6
2.1 INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA 6
2.2 ANATOMIA DA REGIÃO INGUINAL 6
2.2.1 TRIÂNGULO DE HESSELBACH 7
2.2.2 CANAL INGUINAL 7
2.2.3 CORDÃO ESPERMÁTICO 8
2.2.4 CANAL FEMORAL 9
2.2.5 ORIFÍCIO MIOPECTÍNEO 11
2.2.6 MÚSCULOS DA REGIÃO INGUINAL 12
2.2.7 INERVAÇÃO 13
2.3 FISIOPATOLOGIA 15
2.4 EXAME FÍSICO E DIAGNÓSTICO 15
2.5 CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS 17
2.6 TRATAMENTO 18
2.7 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS 21
2.7.1 RECIDIVA HERNIÁRIA 21
2.7.2 DOR CRÔNICA PÓS-OPERATÓRIA E LESÕES NERVOSAS 21
2.7.3 LESÃO TESTICULAR 22
3.0 HÉRNIAS VENTRAIS 24
3.1 HÉRNIA INCISIONAL 24
3.2 HÉRNIA EPIGÁSTRICA 25
3.3 HÉRNIA UMBILICAL 25
4.0 HÉRNIAS INCOMUNS 27
5.0 LISTA DE QUESTÕES 28
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 29
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

CAPÍTULO
1.0 O QUE É UMA HÉRNIA?

Antes de mais nada, precisamos responder a essa questão: o que é uma hérnia, qual é sua definição? Então, para acabar com essa dúvida:

> Hérnia é definida como uma protrusão anormal de um órgão ou tecido devido a um defeito nas paredes circundantes.

O **principal local** em que as **hérnias da parede abdominal** ocorrem é a região inguino-femoral.

As hérnias podem ser:

- **REDUTÍVEIS**, quando seu conteúdo retorna para a cavidade abdominal; ou
- **IRREDUTÍVEIS,** quando seu conteúdo não retorna.
  - Nesse caso, a hérnia pode ser:
  - **ENCARCERADA**, quando o suprimento sanguíneo do conteúdo herniado não está comprometido; ou
  - **ESTRANGULADA**, quando há comprometimento vascular e sofrimento do conteúdo herniado.

ENCARCERADA → irredutível, porém sem sofrimento vascular;
ESTRANGULADA → irredutível, com sofrimento do conteúdo herniado.

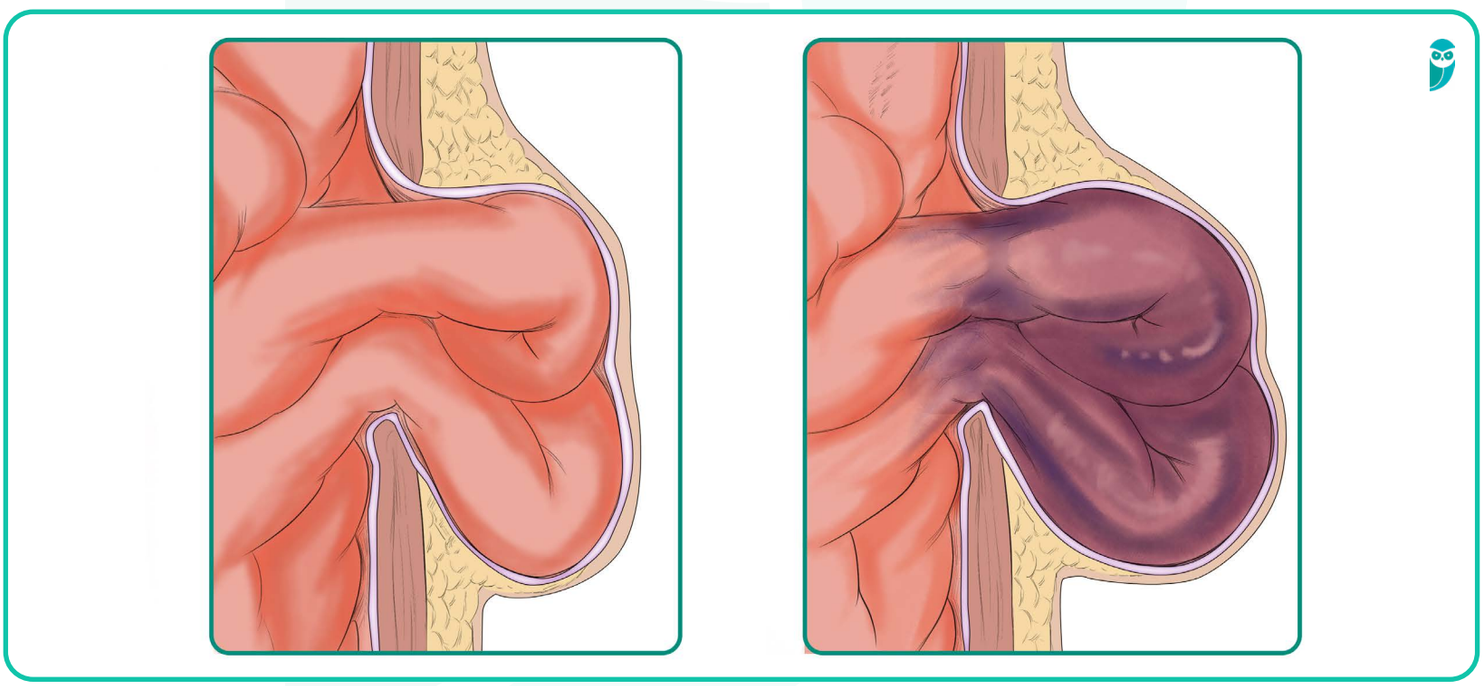


Figura 1: à direita, hérnia encarcerada, cujo conteúdo se torna irredutível; à esquerda, hérnia estrangulada, cujo conteúdo tem sofrimento vascular.

CAPÍTULO
2.0 HÉRNIAS DA REGIÃO INGUINAL

2.1 INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA

Vamos destacar os principais aspectos em relação à incidência e à prevalência das hérnias inguino-femorais, também chamadas hérnias da virilha:

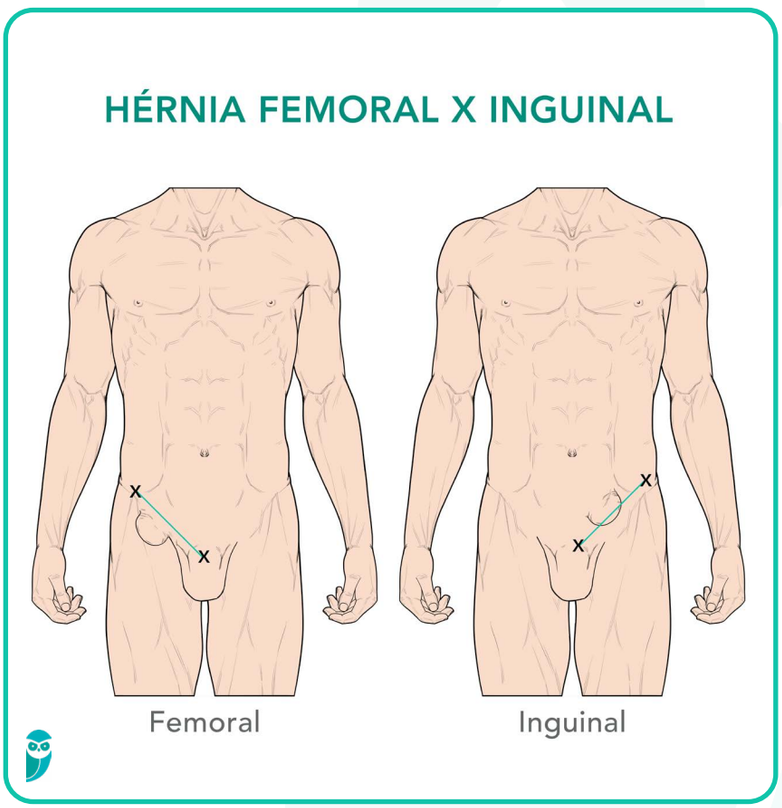


Figura 2: hérnia inguinal X hérnia femoral.

- Hérnia **INGUINAL**: localiza-se **acima** do ligamento inguinal. É dividida em **DIRETA** e **INDIRETA**;
- Hérnia **FEMORAL**.: localiza-se **abaixo** do ligamento inguinal;
- A hérnia **MAIS COMUM** em **AMBOS OS SEXOS** é a hérnia inguinal **INDIRETA**;
- A hérnia femoral é mais comum no sexo feminino (10:1), porém sua incidência total é baixa;
- As hérnias inguino-femorais são mais comuns **à direita** que à esquerda;
- As **hérnias femorais** têm risco muito aumentado de **encarceramento e estrangulamento** (15 a 20% dos casos);
- Já as hérnias inguinais (diretas e/ou indiretas) têm baixo risco de encarceramento/estrangulamento (1 a 3%).

2.2 ANATOMIA DA REGIÃO INGUINAL

Aqui, focaremos nos principais reparos anatômicos que caem em provas.

2.2.1 TRIÂNGULO DE HESSELBACH



Os limites do triângulo de Hesselbach são um dos temas mais frequentes nos concursos de Residência. Ele é muito importante porque as hérnias inguinais **diretas** ocorrem dentro de seus limites.

- **Limite medial:** borda lateral da bainha do músculo reto abdominal;
- **Limite superolateral:** vasos epigástricos inferiores;
- **Limite inferior:** ligamento inguinal (ou de Poupart).

E AQUI VAI UMA DICA VALIOSÍSSIMA:

Hérnia **LATERAL** aos vasos epigástricos inferiores = hérnia inguinal **INDIRETA**;

Hérnia **MEDIAL** aos vasos epigástricos inferiores = **meDIRETA** = hérnia inguinal **DIRETA**.

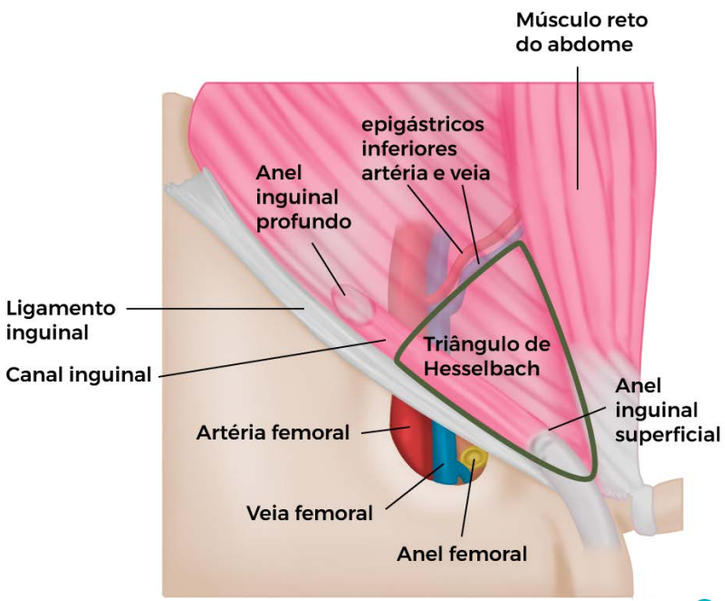


Figura 3: triângulo de Hesselbach.

2.2.2 CANAL INGUINAL

O canal inguinal é um túnel com sentido oblíquo, inclinando-se para baixo, de lateral para medial, paralelo ao ligamento inguinal.

No **sexo feminino**, o principal conteúdo do canal inguinal é o **ligamento redondo**. No **sexo masculino**, o principal componente é o **cordão espermático**, também chamado de funículo espermático.

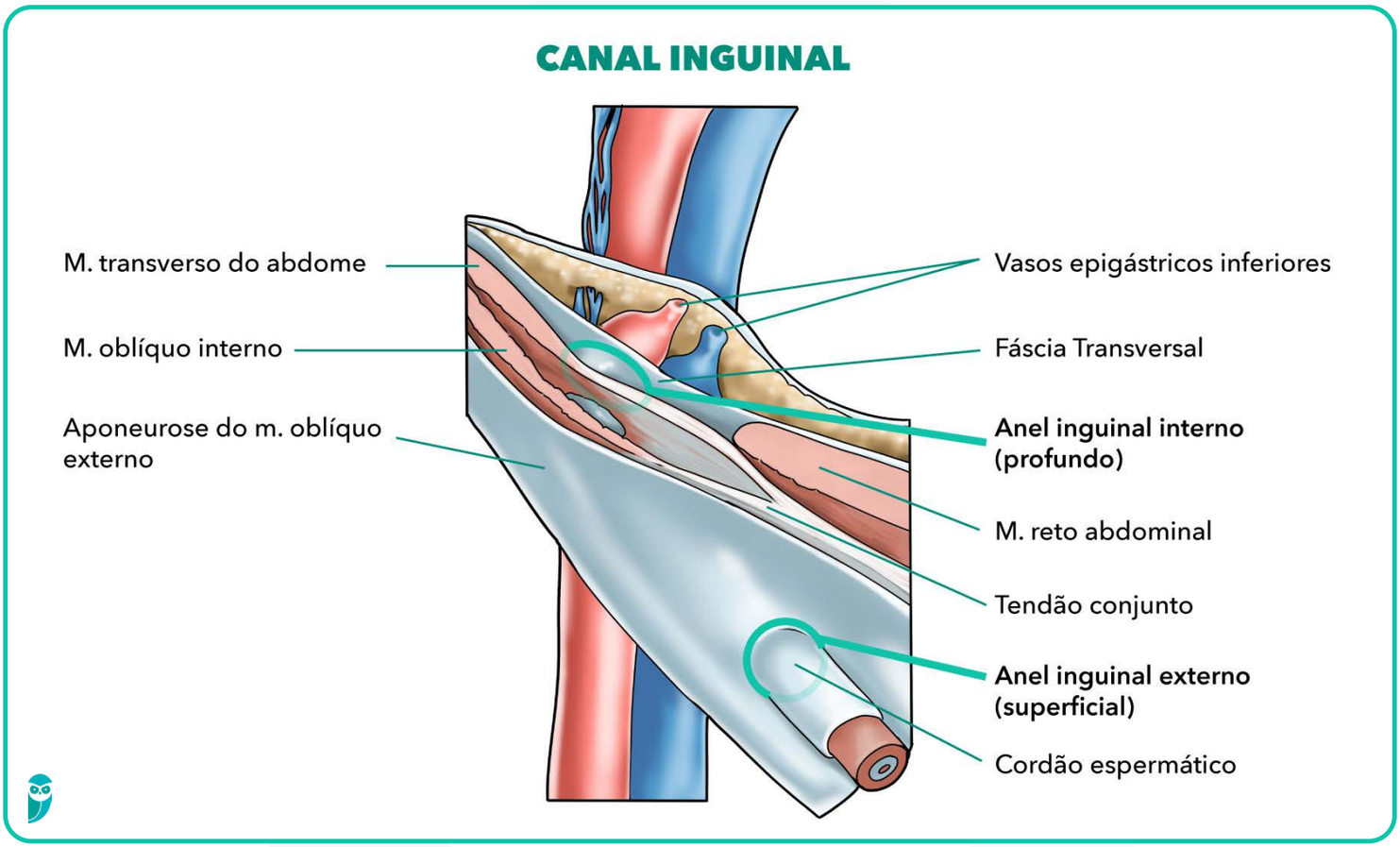


Figura 4: canal inguinal.

Os limites do canal inguinal são um tema que as bancas adoram! Por isso, vamos lá:

- **Limite anterior:** aponeurose do músculo oblíquo externo;
- **Limite lateral:** músculo oblíquo interno;
- **Limite posterior:** fáscia *transversalis* e músculo transverso do abdome;
- **Limite superior:** músculo oblíquo interno;
- **Limite inferior:** ligamento inguinal.

2.2.3 CORDÃO ESPERMÁTICO

O **cordão espermático** é uma estrutura com formato de cordão, constituída pelo ducto deferente e tecido circundante, que se estende para cada um dos testículos. Questões perguntando sobre os componentes do cordão espermático são muito frequentes. Anote aí os principais componentes:

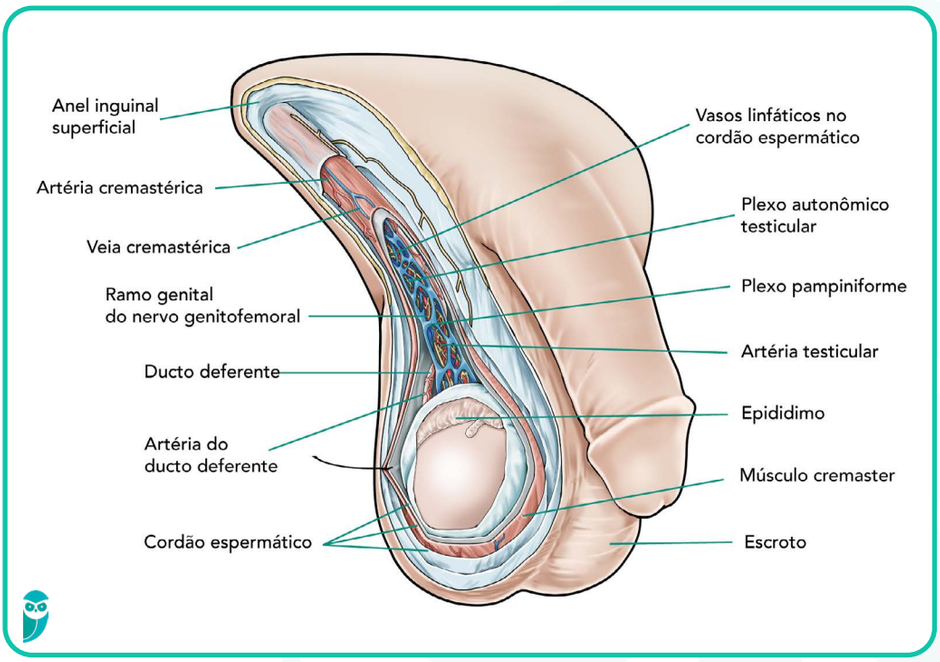


Figura 5: cordão espermático.

- Músculo cremaster;
- Artéria testicular e veias testiculares;
- **Ramo genital do nervo genitofemoral;**
- **Ducto deferente;**
- Artéria cremastérica (ramo da artéria epigástrica inferior);
- Artéria para o ducto deferente (a partir da artéria vesical superior);
- Artéria espermática;
- Plexo testicular simpático;
- 4–8 vasos linfáticos que drenam o testículo;
- **Plexo venoso pampiniforme.**



O **nervo ilioinguinal** não está realmente localizado dentro do cordão espermático, mas corre por fora dele, no canal inguinal. Algumas bancas acabam considerando o nervo ilioinguinal como constituinte do cordão espermático, por isso muita atenção!

2.2.4 CANAL FEMORAL

As hérnias femorais ocorrem pelo alargamento do canal femoral.

Vamos ver os limites desse canal?

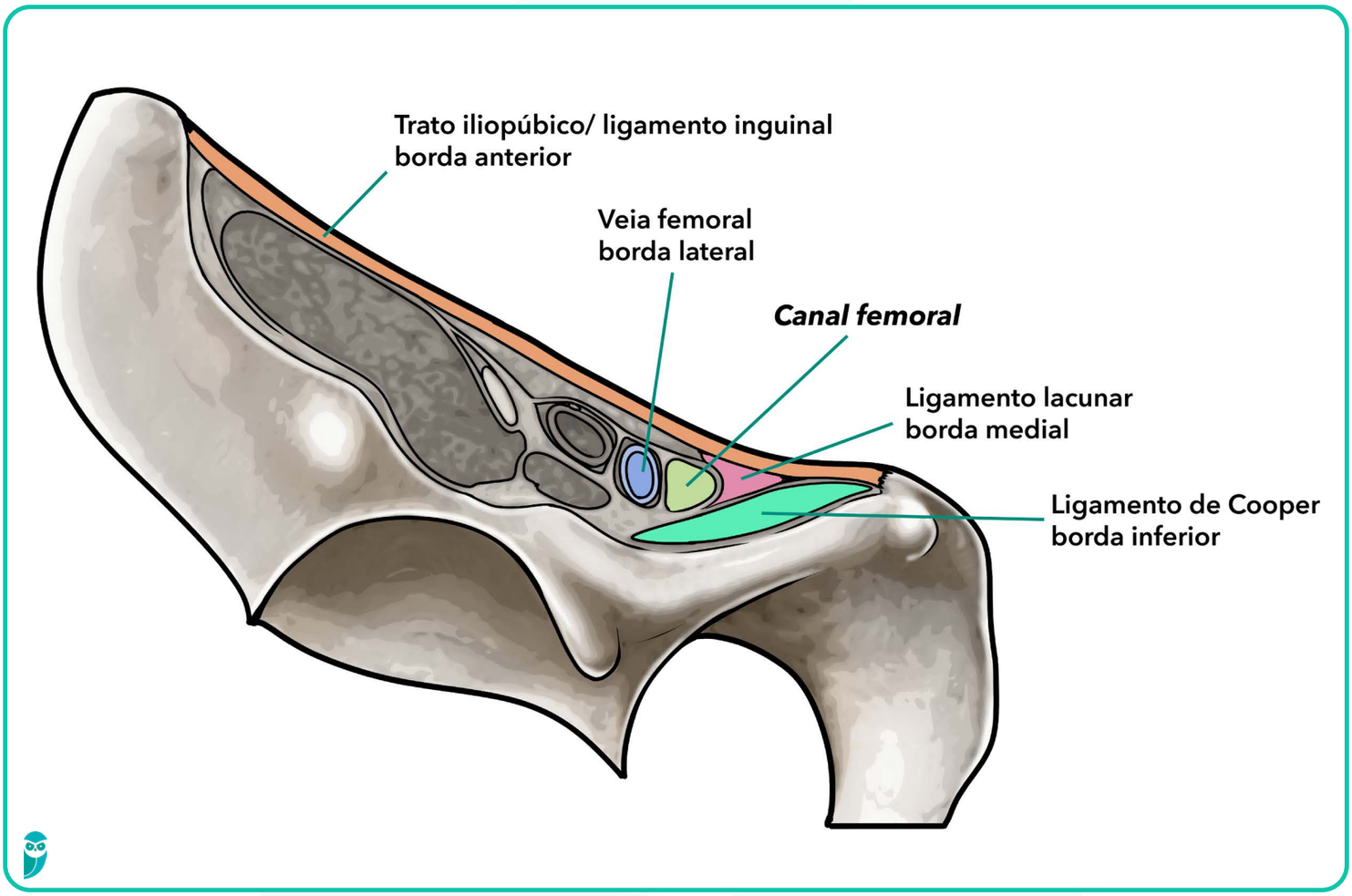


Figura 6: canal femoral.

- **Anterior**: trato iliopúbico/ligamento inguinal;
- **Posterior:** ligamento de Cooper;
- **Lateral:** veia femoral;
- **Medial**: junção do trato iliopúbico e do ligamento de Cooper (formando o ligamento lacunar).

2.2.5 ORIFÍCIO MIOPECTÍNEO

O **orifício miopectíneo**, descrito por **Fruchaud**, em 1956, é uma área de fraqueza da região inguinal que dá origem a todas as hérnias da região, tanto inguinais quanto femorais. O princípio das técnicas de hernioplastia laparoscópica é recobrir essa área com tela.

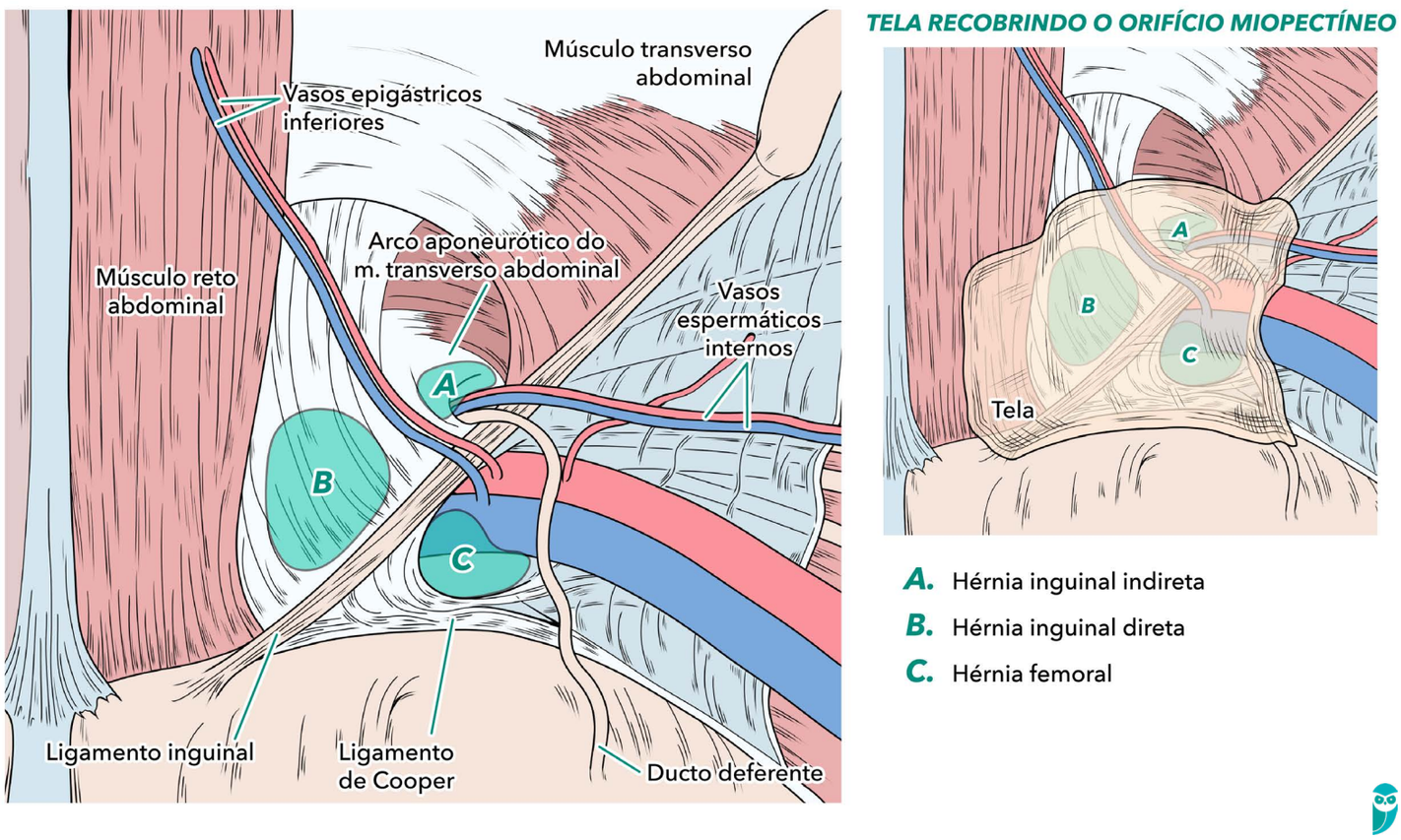


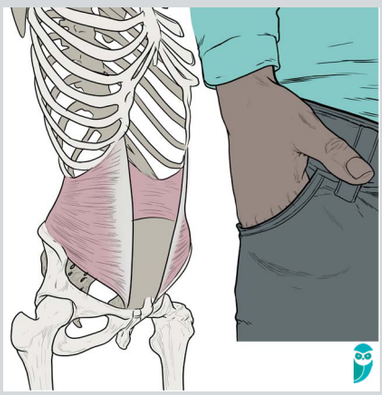
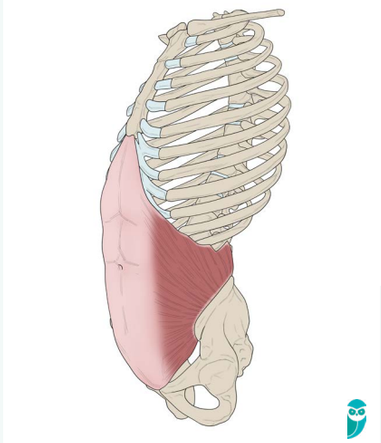
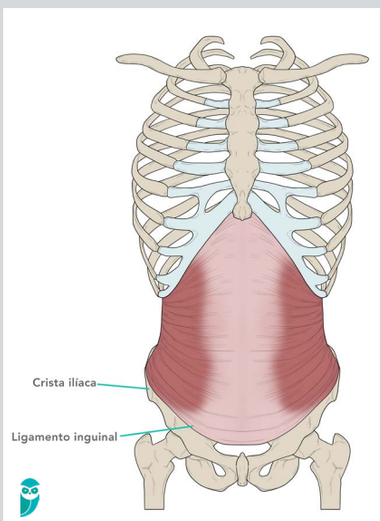
Figura 7: orifício miopectíneo de Fruchaud.

Os limites do orifício miopectíneo de Fruchaud são:

- **Medial**: músculo reto abdominal;
- **Lateral**: músculo psoas;
- **Superior**: músculo transverso abdominal e músculo oblíquo interno (arco transversal); e
- **Inferior**: ligamento pectíneo (Cooper).

2.2.6 MÚSCULOS DA REGIÃO INGUINAL

Vamos ver um resumo com as principais características dessa musculatura:

Músculo	Imagem	Características importantes
M. oblíquo externo		Suas fibras têm a direção de "mãos no bolso" Sua aponeurose dá origem à bainha anterior do m. reto do abdome A aponeurose do músculo forma a parede anterior do canal inguinal
M. oblíquo interno		Suas fibras têm direção perpendicular às fibras do m. oblíquo interno Suas fibras, em conjunto com as fibras do m. transverso do abdome, formam o tendão conjunto Suas fibras dão origem ao m. cremaster
M. transverso do abdome		Suas fibras têm sentido horizontal Sua fáscia é o assoalho do canal inguinal A fraqueza da fáscia é o local de origem das hérnias inguinais diretas A aponeurose do músculo e sua fáscia formam o **trato iliopúbico**, importante referencial para o reparo laparoscópico das hérnias inguino-femorais

2.2.7 INERVAÇÃO

Os principais nervos da região inguinal são os nervos **ílio-hipogástrico**, **ilioinguinal**, **ramo genital do nervo genitofemoral** e **nervo cutâneo femoral lateral.**

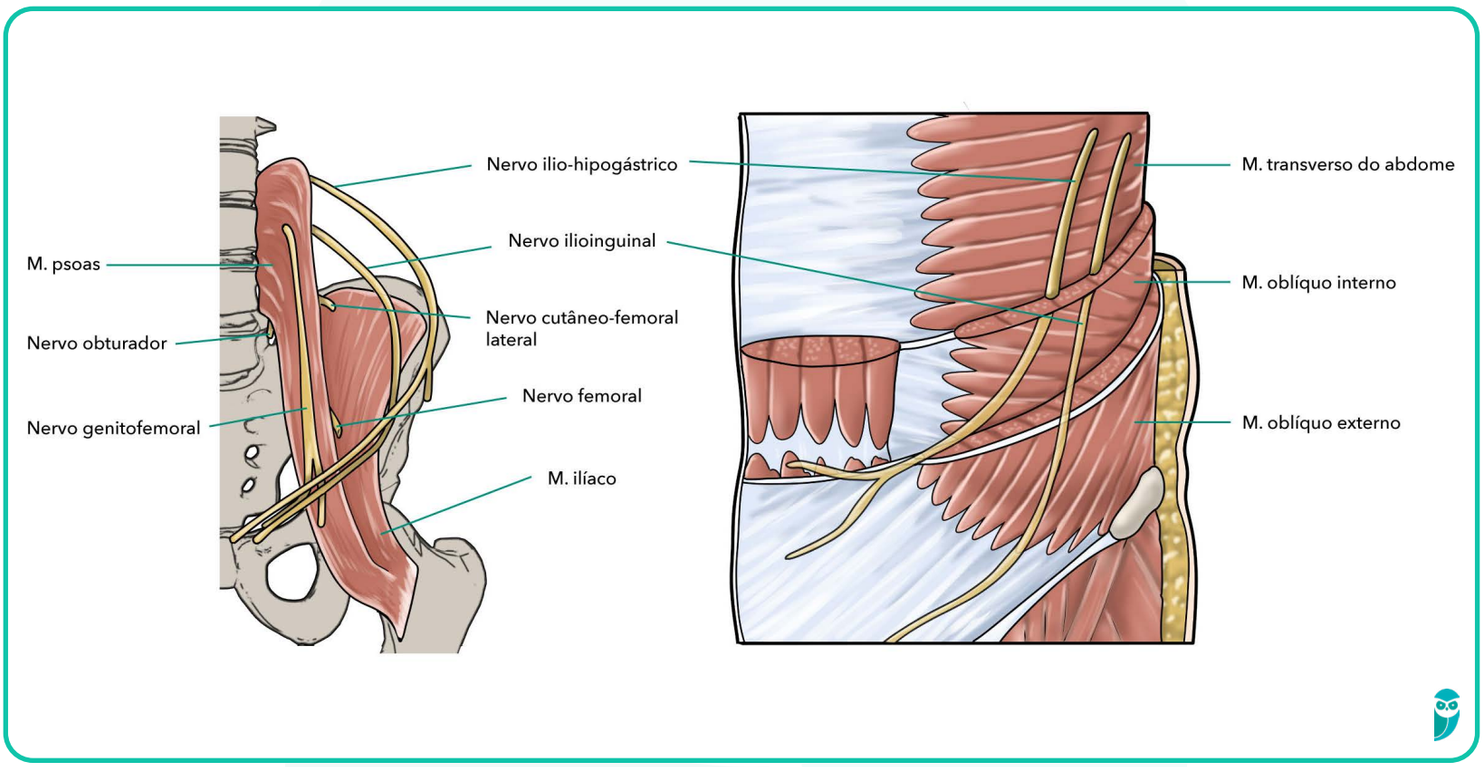


Figura 8: nervos da região inguinal.

Qual é a área que cada um inerva?



Figura 9: inervação sensitiva da região inguinal.

NERVO	INERVAÇÃO SENSITIVA
ILIOINGUINAL	Coxa proximal e medial Monte do púbis e grandes lábios nas mulheres Raiz do pênis e parte superior do escroto nos homens
ÍLIO-HIPOGÁSTRICO	Pele da região hipogástrica e da região glútea
CUTÂNEO FEMORAL LATERAL	Porção anterolateral da coxa
RAMO GENITAL DO NERVO GENITOFEMORAL	Pele da bolsa escrotal em homens Monte do púbis e os grandes lábios da vulva nas mulheres
Todos esses nervos são ramos do PLEXO LOMBAR.	

Hora de entendermos como as hérnias inguinais surgem e a diferença entre as hérnias inguinais DIRETAS e INDIRETAS.

2.3 FISIOPATOLOGIA

Vamos começar pela hérnia mais comum em ambos os sexos, a hérnia inguinal INDIRETA.

O principal mecanismo de formação das hérnias inguinais indiretas é a **PERSISTÊNCIA DO CONDUTO PERITÔNIO VAGINAL**. Por isso, mesmo nos adultos, consideramos as hérnias inguinais indiretas como **CONGÊNITAS**. Então o que é o conduto peritônio vaginal?

Anote aí para não esquecer:



As hérnias inguinais **indiretas** são **hérnias congênitas** devido à **persistência do conduto peritônio vaginal**.

Além da patência, a fraqueza muscular também contribui para o surgimento dessas hérnias.

E as hérnias inguinais diretas e hérnias femorais?

As hérnias inguinais diretas e as hérnias femorais ocorrem devido à **FRAQUEZA MUSCULAR** da parede posterior da região inguinal, que acaba permitindo que o conteúdo intra-abdominal insinue-se. Por isso, elas têm origem **ADQUIRIDA**.



As hérnias inguinais diretas e as hérnias femorais são consequência da **FRAQUEZA MUSCULAR**; portanto, são hérnias **ADQUIRIDAS**.

2.4 EXAME FÍSICO E DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de hérnia inguinal é CLÍNICO!

A queixa mais comum é de **abaulamento na região da virilha, que piora com o esforço físico.**

O paciente deve ser examinado tanto em posição supina (deitado) quanto em posição ortostática (em pé), com a região inguinal desnuda. A **posição ortostática é a preferida**, porque assim temos um aumento da pressão intra-abdominal e isso facilita a protrusão da hérnia.

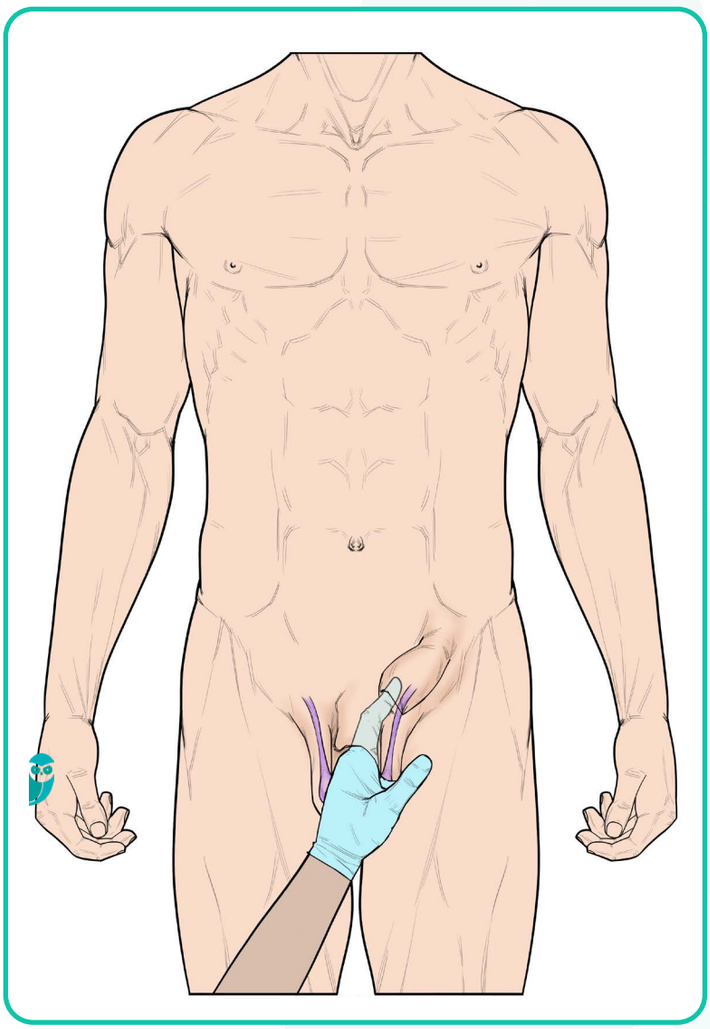


Figura 10: manobra de Landivar.

Com o dedo indicador fechando o anel inguinal externo, nós pedimos para o paciente fazer esforço. Veja:

Se o abaulamento é sentido na **PONTA** digital, estamos diante de uma hérnia inguinal **INDIRETA**.

Se o abaulamento é sentido na **POLPA** digital, estamos diante de uma hérnia inguinal **DIRETA**.

Os exames de imagem devem ser solicitados SOMENTE quando há dúvida diagnóstica. O exame de escolha é a ULTRASSONOGRAFIA DE PARede ABDOMINAL.

Vamos discutir um tema quente em hérnias: **CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS**.



2.5 CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS



Esse é um dos temas que mais caem sobre as hérnias da região inguinal. Ele é cobrado diretamente ou em questões que misturam diversos temas. Ao final do capítulo, darei algumas dicas que vão ajudá-lo a decorar a tabela.

CLASSIFICAÇÃO DE NYHUS	
Tipo I	Hérnia inguinal indireta – anel inguinal interno normal (hérnia pediátrica)
Tipo II	Hérnia inguinal indireta – anel inguinal interno dilatado, mas parede inguinal posterior intacta; vasos epigástricos profundos inferiores não deslocados
Tipo III	Defeito da parede posterior
III A	Hérnia inguinal direta
III B	Hérnia inguinal indireta – anel inguinal interno dilatado, invadindo os limites medialmente ou destruindo a fáscia transversal do triângulo de Hesselbach (p.ex., hérnia inguinoescrotal grande)
III C	Hérnia femoral
Tipo IV	Hérnia recidivada
IV A	Hérnia recidivada direta
IV B	Hérnia recidivada indireta
IV C	Hérnia recidivada femoral
IV D	Hérnia recidivada combinada

Eu sei, eu sei... A classificação é chata, mas vou dar umas dicas para você acertar as questões. Anote aí:

#FICAADICA



- A **hérnia pediátrica (tipo I)** é inguinal **INDIRETA**. O que a diferencia das outras hérnias inguinais é **o anel inguinal interno normal (até 1,0 cm de diâmetro);**
- Há uma confusão comum entre a **hérnia tipo II** e a **hérnia tipo III B.** Veja: ambas são **hérnias inguinais indiretas com anel inguinal interno dilatado**. Então o que as diferencia? A **PAREDE POSTERIOR**! **No tipo III B, há destruição da parede posterior.** Por isso, nas questões de provas, você deve procurar sinônimos de **destruição**. **Já no tipo II, o enunciado dirá assim: "a parede posterior está intacta", "está preservada" etc.;**
- **Hérnia femoral é sempre tipo III C.** Lembre-se disso e poupará tempo e esforço;
- **Hérnia inguinal direta é sempre tipo III A**. Se, no texto, você identificar que o anel inguinal interno está preservado e que há destruição ou fraqueza da parede posterior, vá na fé! Outra dica: se estiver escrito que a **herniação ocorre pelo triângulo de Hesselbach**, lembre: a questão está se referindo à **hérnia inguinal direta**;
- **Hérnias recidivadas são tipo IV.** Para identificar esse tipo de hérnia, basta seguir a mesma ordem das do tipo III: tipo IV A → direta; tipo IV B → indireta; tipo IV C → femoral; e tipo IV D → combinada.

2.6 TRATAMENTO

Podemos dividir o tratamento das hérnias da região inguinal em três tipos:

- tratamento conservador, também conhecido como espera vigilante (*watchful waiting*);
- tratamento cirúrgico aberto, com ou sem tela;
- tratamento cirúrgico laparoscópico.

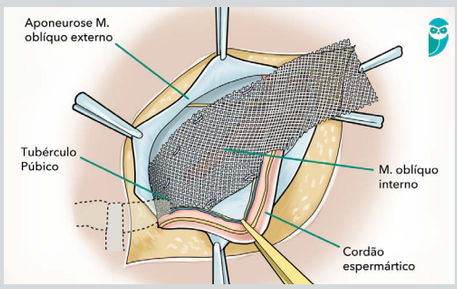
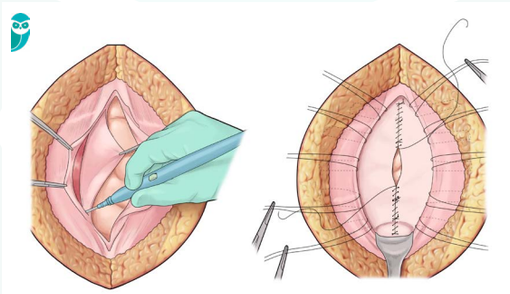
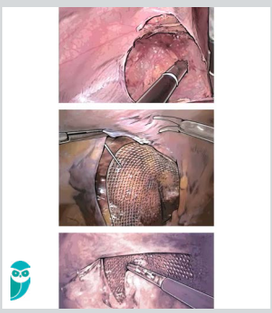
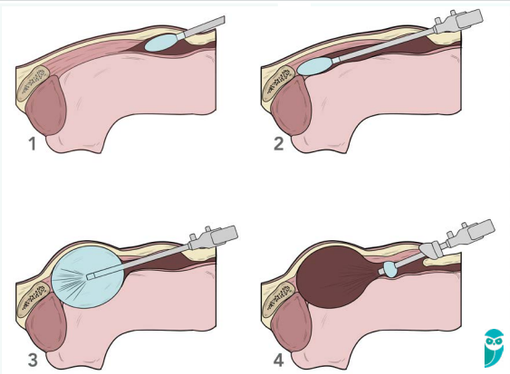
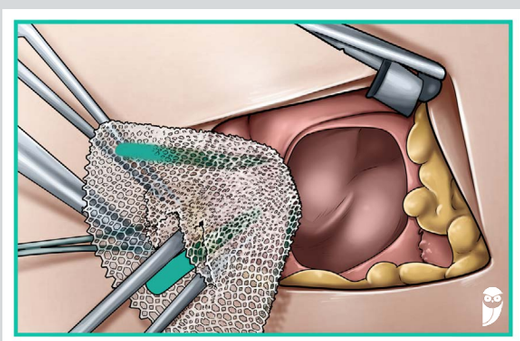
FIQUE ATENTO!

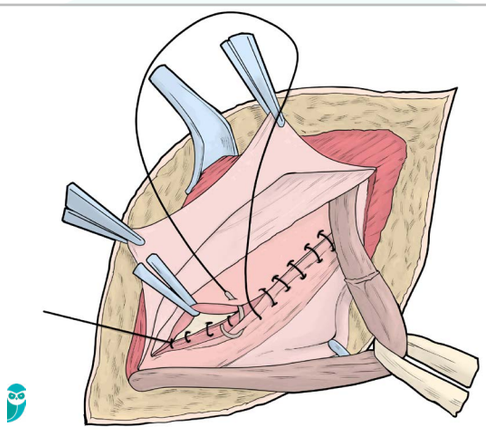
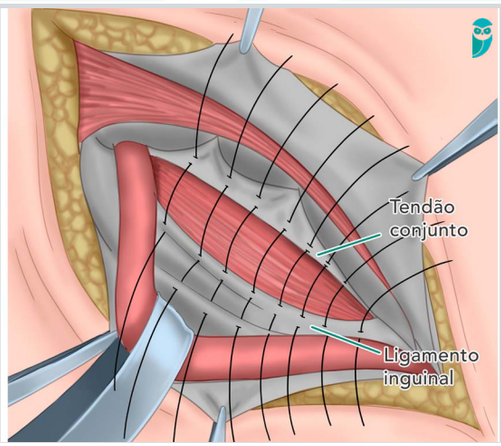
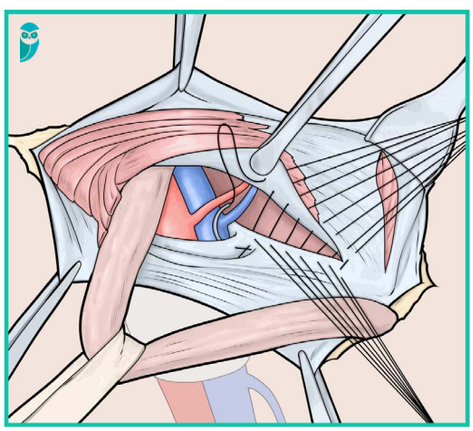


Qual paciente é candidato ao tratamento conservador?

Pacientes **ASSINTOMÁTICOS**, **OLIGOSSINTOMÁTICOS** ou com **RISCO CIRÚRGICO ELEVADO** → considerar ESPERA VIGILANTE (*WATCHFUL WAITING*).

Vamos ver no quadro abaixo as principais características do tratamento cirúrgico:

TRATAMENTO	EPÔNIMO	IMAGEM	CARACTERÍSTICAS
Com tela Sem tensão	Lichtenstein		Técnica padrão-ouro. Fixação da tela ao tubérculo púbico e ao tendão conjunto. Baixos índices de recidiva.
	Stoppa-Rives		Colocação de tela pré-peritoneal. Mais indicado para o tratamento de hérnias inguinais bilaterais.
	TAPP		Técnica laparoscópica transabdominal. Menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida.
	TEP		Técnica laparoscópica extraperitoneal. Menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida. A tela não necessita de fixação com grampos. Necessita de instrumental apropriado, o que aumenta seu custo.
	Mesh-plug (plug femoral)		Técnica mais indicada para correção da hérnia femoral não complicada. *Plug* de tela de polipropileno fecha o canal femoral.

Sem tela **Com tensão**	Shouldice		Imbricamento de múltiplas camadas musculares. Em pacientes selecionados e clínicas especializadas, apresenta baixas taxas de recidiva.
	Bassini		Sutura do tendão conjunto ao ligamento inguinal. Altas taxas de recidiva herniária.
	McVay		Sutura do tendão conjunto ao ligamento de Cooper. Única técnica aberta sem tela que corrige as hérnias femorais.
	Reparo com o trato iliopúbico	Aproximação do arco aponeurótico do m. transverso do abdome ao trato iliopúbico, com o uso de suturas interrompidas.	
	Zimmerman	Sutura da fáscia transversal ao ligamento inguinal.	
	Andrews I	Três linhas de sutura em camadas, sendo que a 1ª linha aproxima a fáscia transversal e os mm. oblíquo interno e transverso do abdome ao ligamento inguinal.	
	Andrews II	Três linhas de sutura em camadas, sendo que a 1ª linha aproxima somente a fáscia transversal ao ligamento inguinal.	

2.7 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS

As principais complicações relacionadas à cirurgia de hérnia são:

- recidiva herniária;
- dor crônica pós-operatória; e
- lesão testicular.

Vamos ver as principais características de cada uma.

2.7.1 RECIDIVA HERNIÁRIA

Com o surgimento das técnicas sem tensão, que utilizam tela protética para o reparo das hérnias, o risco de recidiva caiu muito. Nas provas, as bancas gostam de perguntar sobre os locais mais comuns de recidiva na técnica de Lichtenstein e qual a melhor técnica para abordar a recidiva. Vamos direto ao ponto:

Locais mais comuns de recidiva herniária na técnica de Lichtenstein:

1º) junto ao tubérculo púbico; e

2º) junto ao anel inguinal interno.

As técnicas laparoscópicas apresentam taxas de recidiva herniária MAIORES do que a técnica de Lichtenstein. Isso se deve à curva mais longa de aprendizado.

Quanto ao tratamento, sempre utilize a máxima:



É preferível trabalhar numa área virgem de tratamento, porque o risco de dor crônica e de lesões vascular e nervosa é menor.

Se o paciente foi operado por meio de reparo aberto anterior, dê preferência ao reparo posterior laparoscópico e vice-versa.

2.7.2 DOR CRÔNICA PÓS-OPERATÓRIA E LESÕES NERVOSAS

A dor crônica pós-operatória, que persiste por mais de 3 meses após a cirurgia, recebe o nome de **INGUINODINIA.** Ela costuma ter características tanto nociceptiva quanto neuropática, sendo de difícil tratamento.

A tríade clínica que deve levantar a suspeita diagnóstica de NEURALGIA PÓS-HERNIORRAFIA/HERNIOPLASTIA consiste em:

- **dor em queimação ou pontada/facada ao longo de uma distribuição específica do nervo da virilha;**
- **evidência de alteração na sensibilidade no trajeto do nervo;**
- **dor que é aliviada por infiltração anestésica no nervo.**

NERVOS EM RISCO DE LESÃO PARA CADA UM DOS REPAROS	
REPARO ABERTO	• Nervo ilioinguinal; • Nervo ílio-hipogástrico; • Ramo genital do nervo genitofemoral.
REPARO LAPAROSCÓPICO	• Nervo cutâneo lateral femoral; • Nervo genitofemoral.

O tratamento dependerá dos sintomas e do grau das queixas, indo desde o bloqueio anestésico até a reoperação para retirada da tela.

2.7.3 LESÃO TESTICULAR

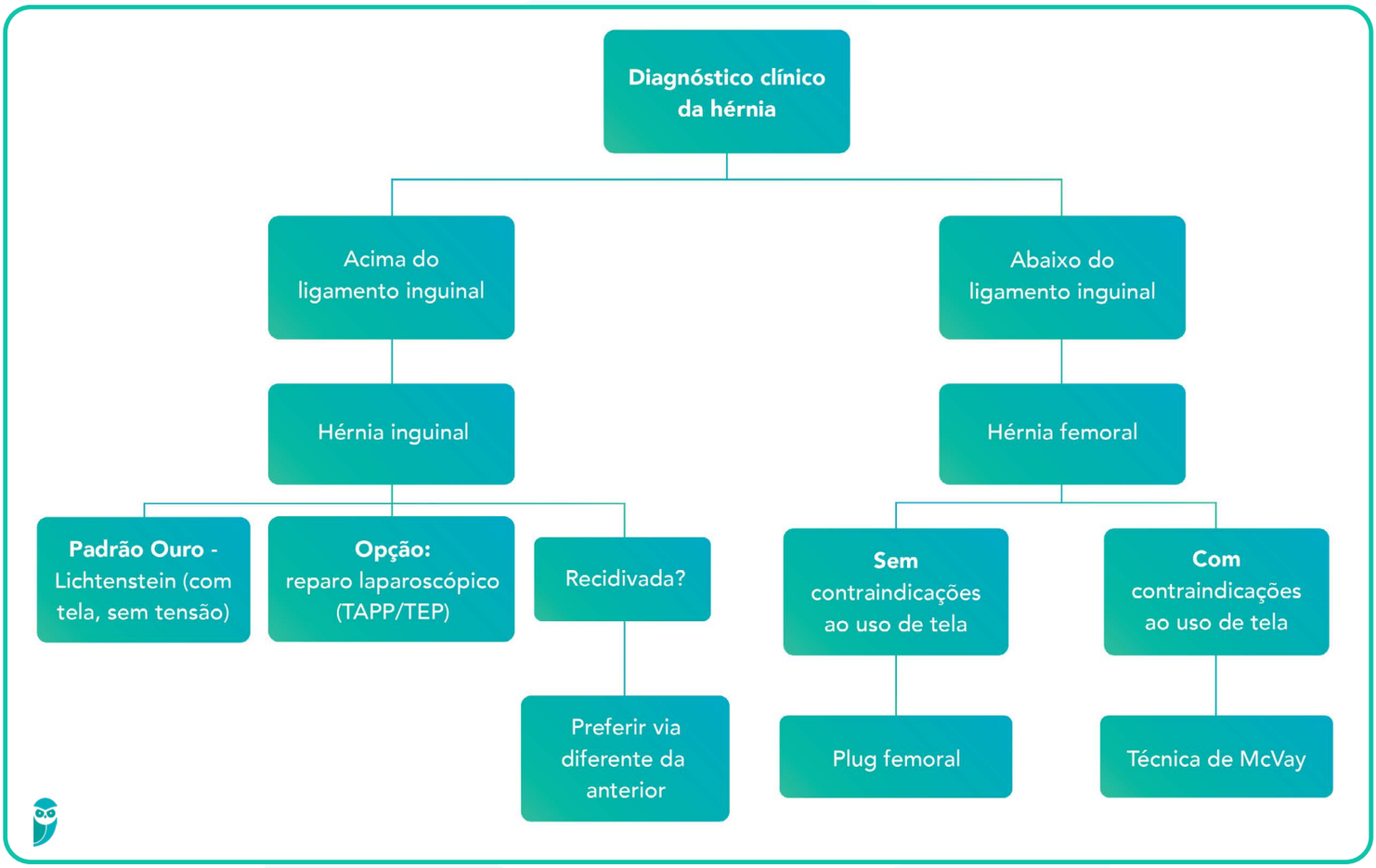
As principais complicações que afetam os testículos são o hematoma de bolsa escrotal e a orquite isquêmica. Vamos começar pela última.

A **ORQUITE ISQUÊMICA** ocorre por uma lesão venosa, especificamente, uma **lesão ao plexo pampiniforme** no cordão espermático. Ela costuma manifestar-se dentro de 1 semana após a cirurgia, com um testículo aumentado de tamanho, endurecido e doloroso, do mesmo lado operado, e pode levar à atrofia testicular.

Qual é o tratamento? O tratamento consiste em analgesia e uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Raramente a orquiectomia é necessária.

Outra complicação possível nas herniorrafias/hernioplastias em que há grande dissecção do cordão espermático é o **hematoma de bolsa escrotal.** Nessa situação clínica, o escroto ou a base do pênis podem adquirir uma coloração arroxeada típica. O tratamento, nessa situação, é clínico. São raras as ocasiões que exigem abordagem para a drenagem do hematoma.

Veja um fluxograma que o ajudará nas questões sobre hérnias inguinais:



Encerramos por aqui as hérnias inguino-femorais. Hora de falarmos das hérnias ventrais!!!

CAPÍTULO
3.0 HÉRNIAS VENTRAIS

Dando prosseguimento ao nosso resumo, falaremos das hérnias da parede anterior do abdome. Ao lado de cada uma delas, está a frequência com que elas caem nas provas (em porcentagem):

- **hérnia incisional (60,9%);**
- **hérnia epigástrica (21,7%);**
- **hérnia umbilical (17,4%).**

3.1 HÉRNIA INCISIONAL

O principal fator causal das hérnias incisionais é a **infecção de sítio cirúrgico.** Anote aí outros fatores de risco para as hérnias incisionais:

FATORES DE RISCO PARA HÉRNIA INCISIONAL			
Tabagismo	DPOC	Idade superior a 70 anos	Sexo feminino
Diabetes mellitus tipo 2	Ascite	Anemia	Infecção de ferida operatória
Cirurgia de urgência	Obesidade	Fechamento de aponeurose sob tensão	Técnica de sutura inadequada
Incisões de comprimento longo (superior a 18 cm)	Desnutrição	Uso de corticoides	Utilização de fios rapidamente absorvíveis

Em pacientes com hérnias incisionais volumosas, com largura > 10 cm ou com perda de domicílio (relação volume do saco herniário e da cavidade abdominal > 25%), o exame de imagem com tomografia computadorizada é indicado para o planejamento cirúrgico.

O tratamento da hérnia incisional é cirúrgico, podendo ser feito por técnica aberta ou laparoscópica. Nas hérnias incisionais grandes, a **melhor opção ainda é a técnica aberta**.

Duas técnicas especiais de tratamento das hérnias incisionais costumam ser cobradas:

- **Separação dos componentes:** consiste na divisão medial da bainha do reto e sua separação do músculo reto abdominal. Além dessa secção, podemos dividir a aponeurose do m. oblíquo externo lateralmente à linha semilunar. Com essas duas divisões, é possível ganhar 10 cm para aproximar as bainhas do reto abdominal.
- **Pneumoperitônio progressivo pré-operatório**: consiste na progressiva realização de pneumoperitônio nos pacientes com hérnias volumosas. As administrações repetidas de volumes crescentes de ar, durante 1 a 3 semanas, permitem que os músculos da parede abdominal se tornem frouxos o suficiente para o fechamento primário do defeito.

Nas **hérnias incisionais pequenas (≤ 2 a 3 cm de diâmetro)**, o reparo primário, sem a utilização de tela, **é possível**. No entanto, nas **hérnias incisionais > 3 cm,** o uso da tela protética está indicado.

3.2 HÉRNIA EPIGÁSTRICA

As hérnias epigástricas ocorrem no espaço compreendido entre o processo xifoide e a cicatriz umbilical (figura abaixo).

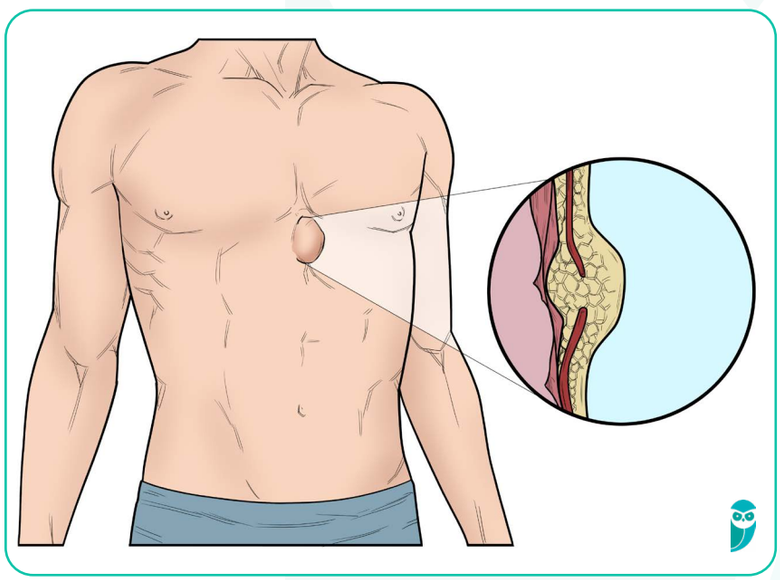


Figura 11: hérnia epigástrica.

Vamos ver algumas características da hérnia epigástrica:

- incidência em 3 a 5% da população;
- é mais comum no sexo masculino (3:1);
- pode ser múltipla em 20% dos pacientes;
- a maioria (80%) ocorre na linha média;
- a idade média do diagnóstico é entre 20 e 50 anos;
- ocorre por uma fraqueza congênita na linha alba, principalmente em pacientes que apresentam **decussação aponeurótica única;**
- é frequente o encarceramento da gordura pré-peritoneal, que pode levar à dor. O encarceramento de alças intestinais é raro;
- a maioria não necessita de reparo com tela, por conta do orifício herniário pequeno.

3.3 HÉRNIA UMBILICAL

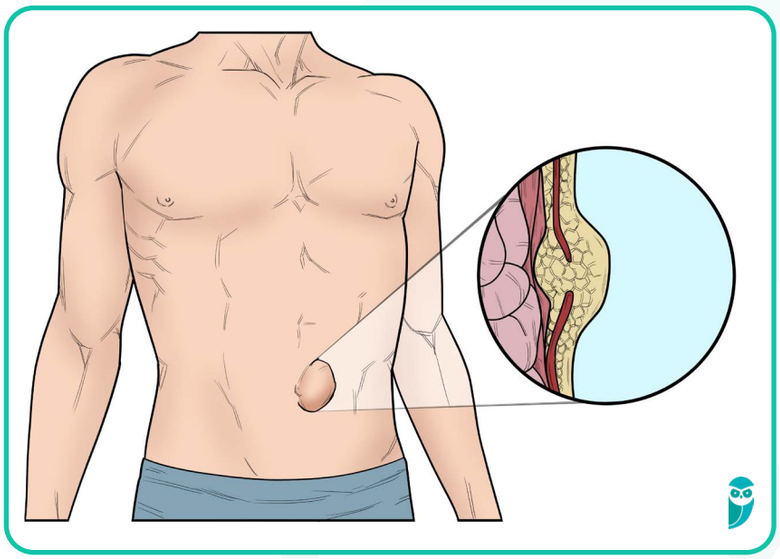


Figura 12: hérnia umbilical.

Na população adulta, a maioria das hérnias umbilicais é **ADQUIRIDA**. As condições clínicas que favorecem seu aparecimento são as que geram aumento da pressão intra-abdominal. Ela é mais comum no sexo masculino e o encarceramento da gordura abdominal pode levar à dor. Assim como na hérnia epigástrica, pacientes que apresentam **decussação aponeurótica única** têm maior risco de ter hérnia umbilical.

- **Pacientes sintomáticos têm indicação de tratamento cirúrgico.**
- **Defeitos maiores que 3 cm (> 3 cm) devem utilizar tela protética em seu reparo.**

CAPÍTULO
4.0 HÉRNIAS INCOMUNS

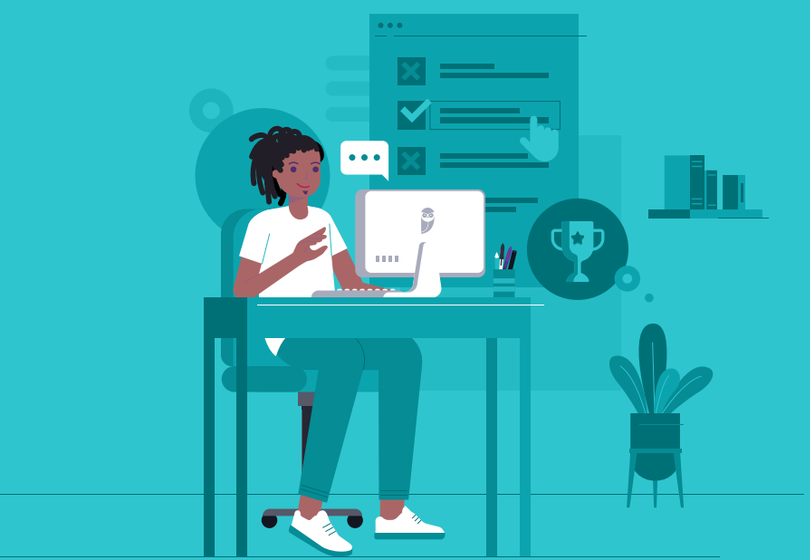
Por que são especiais? Porque, por suas características, são conhecidas pelos seus epônimos... E as bancas adoram cobrar epônimos!

Vamos de resuminho básico para as hérnias incomuns?

HÉRNIAS "ESPECIAIS"	
LITTRÉ	Contém um divertículo de Meckel no saco herniário.
AMYAND	Hérnia **INGUINAL** que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não.
GARENGEOT	Hérnia **FEMORAL** que contém um APÊNDICE CECAL, inflamado ou não.
RICHTER	Pinçamento da borda antimesentérica da alça intestinal. Podem ocorrer necrose e perfuração da alça intestinal, sem sinais ou sintomas de obstrução intestinal.
POR DESLIZAMENTO	A parede do saco herniário é formada por uma víscera abdominal.
EM PANTALONA	Hérnia inguinoescrotal grande, com componente de hérnia inguinal direta e indireta.
SPIEGEL	Hérnia da parede abdominal anterolateral, que ocorre na fáscia de Spiegel, entre o m. reto abdominal e a **linha semilunar.**
GRYNFELT	Hérnia do trígono lombar superior. É a hérnia lombar congênita mais comum.
PETIT	Hérnia do trígono lombar inferior. É a hérnia lombar congênita menos comum.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/2pFW

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Neste espaço, deixarei as principais referências utilizadas para a produção do livro e artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar em alguns assuntos.

1. Ruhl, C.E.; Everhart, J.E. *Risk factors for inguinal hernia among adults in the US population*. Am J Epidemiol. 2007;165(10):1154-1161. doi:10.1093/aje/kwm011

2. O'Dwyer, P.J.; Norrie, J.; Alani, A.; Walker, A.; Duffy, F.; Horgan, P. *Observation or operation for patients with an asymptomatic inguinal hernia: a randomized clinical trial*. Ann Surg. 2006;244(2):167-173. doi:10.1097/01.sla.0000217637.69699.ef

3. Bay-Nielsen, M.; Kehlet, H.; Strand, L. et al. *Quality assessment of 26,304 herniorrhaphies in Denmark: a prospective nationwide study*. Lancet. 2001;358(9288):1124-1128. doi:10.1016/S0140-6736(01)06251-1

4. Schumpelick, V.; Treutner, K.H.; Arlt, G. *Inguinal hernia repair in adults*. Lancet. 1994;344(8919):375-379. doi:10.1016/s0140-6736(94)91404-4

5. Fitzgibbons, R.J.; Giobbie-Hurder Jr., A.; Gibbs, J.O. et al. *Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial*. JAMA 295:285–292, 2006.

6. Simons, M.P.; Aufenacker, T.; Bay-Nielsen, M. et al. *European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients*. Hernia. 2009;13(4):343-403. doi:10.1007/s10029-009-0529-7

7. Inaba, T.; Okinaga, K.; Fukushima, R. et al. *Chronic pain and discomfort after inguinal hernia repair*. Surg Today. 2012;42(9):825-829. doi:10.1007/s00595-012-0153-5

8. Alfieri, S.; Amid, P.K.; Campanelli, G. et al. *International guidelines for prevention and management of post-operative chronic pain following inguinal hernia surgery*. Hernia. 2011;15(3):239-249. doi:10.1007/s10029-011-0798-9

9. Hawn, M.T.; Itani, K.M.; Giobbie-Hurder, A.; McCarthy Jr, M.; Jonasson, O.; Neumayer, L.A. *Patient-reported outcomes after inguinal herniorrhaphy*. Surgery. 2006;140(2):198-205. doi:10.1016/j.surg.2006.02.003

10. Weyhe, D.; Schmitz, I.; Belyaev, O.; Grabs, R.; Müller, K.M.; Uhl, W.; Zumtobel, V. *Experimental comparison of monofile light and heavy polypropylene meshes: less weight does not mean less biological response*. World J Surg 2006, 30:1586-1591.

11. Hawn, M.T.; Itani, K.M.; Giobbie-Hurder, A.; McCarthy Jr., M.; Jonasson, O.; Neumayer, L.A. Patient-reported outcomes after inguinal herniorrhaphy. Surgery. 2006;140(2):198-205. doi:10.1016/j.surg.2006.02.003

12. Halligan, S.; Parker, S.G.; Plumb, A.A.; Windsor, A.C.J. *Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications*. Eur Radiol. 2018;28(8):3560-3569. doi:10.1007/s00330-018-5328-z

13. Ramirez, O.M.; Ruas, E.; Dellon, A.L. *"Components separation" method for closure of abdominal-wall defects: an anatomic and clinical study*. Plast Reconstr Surg. 1990;86(3):519-526. doi:10.1097/00006534-199009000-00023

14. Marsman, H.A.; Heisterkamp, J.; Halm, J.A.; Tilanus, H.W.; Metselaar, H.J.; Kazemier, G. *Management in patients with liver cirrhosis and an umbilical hernia*. Surgery. 2007;142(3):372-375. doi:10.1016/j.surg.2007.05.006

15. Polistina, F.A.; Garbo, G.; Trevisan, P.; Frego, M. *Twelve years of experience treating Spigelian hernia.* Surgery. 2015;157(3):547-550. doi:10.1016/j.surg.2014.09.027

16. Townsend, C. M.; Beauchamp, R. D.; Evers, B. M.; Mattox, K. L. (2017). Sabiston Textbook of Surgery: *the biological basis of modern surgical practice*, Elsevier Saunders.

17. Brunicardi, F. C.; Andersen, D. K.; Billiar, T. R.; Dunn, D. L.; Hunter, J. G.; Matthews, J. B.; Pollock, R. E. (2014). *Schwartz's Principles of Surgery*, 10th edition, McGraw-Hill Education.

18. Standring, S.; Borley, N. R.; & Gray, H. (2008). *Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice*. 40th ed., anniversary ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone/Elsevier.

19. Lex, A. (1963). Hérnias em geral: revisão didática. Revista de Medicina, 47(1), 13-38. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v47i1p13-38

CAPÍTULO

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

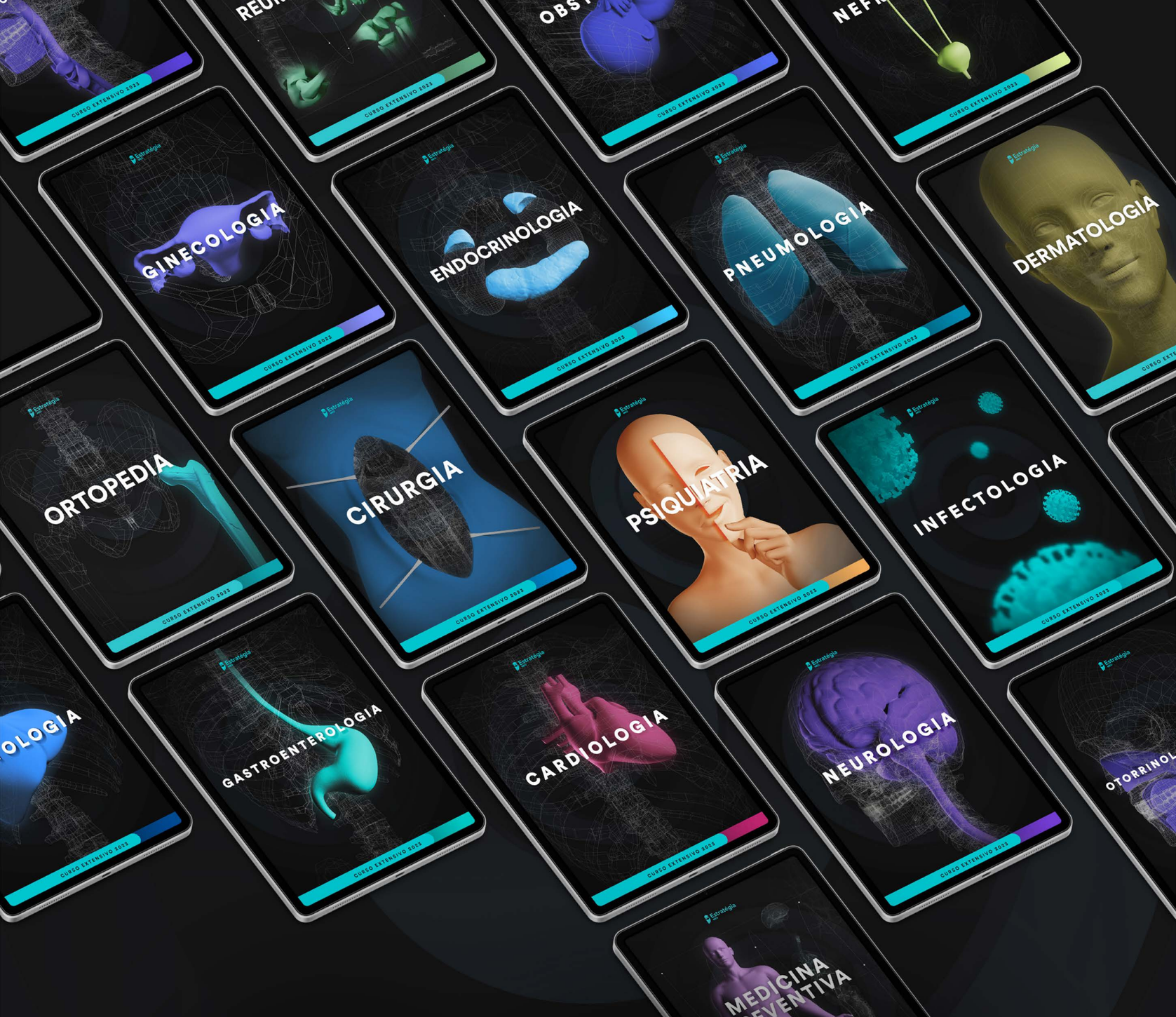
O tema Hérnias da Parede Abdominal é bem extenso. Com este resumo estratégico, nosso objetivo é apresentar, de forma condensada, as principais características de cada uma delas, que o ajudarão a resolver a maioria das questões sobre o tema.

É fundamental que você responda muitas questões sobre o tema, para sedimentar o conhecimento e colocar em prática os conceitos presentes aqui.

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO E UM FORTE BEIJO!!

"A persistência é o caminho do êxito."

Charles Chaplin



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED